Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Trachéotomie : canule bouchée ou retirée (IDE)

Adulte et enfant trachéotomisés (MAS, FAM, IEM) · O2 et 15 d'abord, geste ensuite

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · ne respire pas, cyanose, SpO2 < 90 %, détresse ; saignement ; emphysème sous-cutané ; échec de recanulation ; **canule sortie, ou bouchée sans reprise immédiate**.

J'applique si

- Canule **bouchée** : sonde d'aspiration qui bute, sifflement, détresse, alarme « haute pression ».
- Canule **sortie** ou déplacée : fuite, alarme « basse pression ».

Je n'applique pas → avis médical

- **Trachéotomie < 10 jours** : ne pas recanuler → O2 sur l'orifice et le visage, 15.
- **Ne jamais forcer** (faux trajet) ; une seule tentative en taille inférieure.
- **Laryngectomie** : O2 et BAVU sur la stomie uniquement.
- Ballonnet gonflé sous **valve phonatoire** : jamais (asphyxie).

J'agis

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

1. **O2 haute concentration** sur l'orifice **et** le visage ; **15** en parallèle des gestes.
2. Respiration insuffisante : **BAVU** sur la canule (≈ 12/min) ou sur l'orifice.

RÔLE PROPRE

3. Bouchée : retirer valve ou bouchon et **canule interne** ; aspirer.
4. Toujours bloquée : **dégonfler le ballonnet**, puis retirer la canule et recanuler.

SUR CE PROTOCOLE D'URGENCE

5. Sortie (trachéo mature) : tête en extension, **Laborde** ; canule **même taille**, rotation vers le bas.
6. Échec : **taille inférieure**. Réussite : ballonnet gonflé, cordon fixé (un doigt de jeu).
7. Contrôle : la sonde d'aspiration passe, le souffle revient, la **SpO2 remonte**.

Au lit, en permanence

Fiche trachéo : date, taille, ballonnet

Canule **même taille** + **taille inférieure**

Laborde · aspiration · O2 · BAVU

- 1er changement de canule : par un médecin (arrêté du 26/06/2026)

J'appelle le médecin

- Après recanulation : **médecin dans l'heure** (position, cause).
- Sécrétions sanglantes ou purulentes, fièvre ; matériel de secours incomplet.

Je surveille et je trace

- SpO2, FR, conscience **/15 min pendant 1 h** ; heure, cause, canule posée ; matériel vérifié à chaque poste.
- AS/AP : aspiration sur orifice cicatrisé seulement ; ni recanulation ni O2.
- **Compte rendu écrit, daté, signé**, remis au médecin (R4311-7).

À retenir : Oxygène et 15 d'abord, geste ensuite. Trachéotomie de moins de 10 jours : on oxygène, on ne recanule pas.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Art. R4311-7 CSP ; arrêté du 26/06/2026 (actes IDE) : art. 1 III (soins, aspirations), art. 4 II (changement de canule, 1er par un médecin), art. 2 B (aspiration AS/AP) ; HAS, Flash sécurité patient « Trachéo, quand la vie ne tient qu'à un tuyau » (29/02/2024) ; SPLF, procédures GAVO2 trachéotomie (08/2021) ; NTSP via APSF Newsletter (06/2025).

Réf. DOTR-IDE-TRACH | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature